

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: MARIA APARECIDA DE ASSIS SANTOS

Sexo: Feminino

Data do Exame: 03-03-2025

Idade: 75 anos

Peso: 75 kg

Altura: 1,62 m

Médico Solicitante: DRA. CLAUDINA FREITYAS DE MORAES OGRIZEK

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 03/03/2025 22:04 e finalizado às 04/03/2025 05:42.

A latência para início do sono foi de **13,5 min** e a latência para o sono REM de **6,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 394,0 min, com eficiência do sono de **86,7 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **7,4 %** de estágio N1, **45,3 %** de estágio N2, **11,2 %** de estágio N3 e **36,2 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 47,0 min. Ocorreram 63 despertares, sendo o índice de **8,3 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 135, sendo 24 apneias obstrutivas, 1 apneias centrais, 0 apneias mistas, 110 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **20,6 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 33,7 e o IDR durante o sono NREM foi de 13,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 20,6 (nº/h), sendo 3,8 apneia/h e 16,8 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 91%, a média de 89% e a mínima de 72%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 20,2 (nº/h), sendo que em REM foi de 40,4 (nº/h) e em NREM foi de 13,1 (nº/h). Permaneceu 53,3 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

Nome: MARIA APARECIDA DE ASSIS SANTOS

Data do Exame: 03-03-2025

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**20,6 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina (**72%**) (VN= >90%);
3. Latência para o início do sono (**13,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**6,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**86,7 %**) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares **8,3 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (**7,4 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**45,3 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**11,2 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**36,2 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

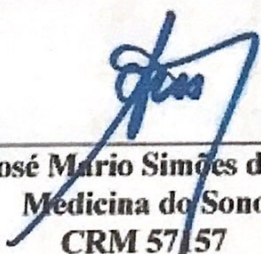
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57



Clínica Centro

Dra. Claudina Freitas de Moraes Ogrizek

Otorrinolaringologia

Clínica e Cirurgia de Ouvidos - Nariz e Garganta

Audiometria - Nasofaringolaringoscopia

CRM 58327

Dr. Eugênio Maik Ogrizek

Oftalmologia

Clínica e Microcirurgia dos Olhos

Lentes de Contato

CRM 58329

✓ Maria Aparecida de A. Santos

Encaminhado para regulagem
do seu CPAP de acordo com sua
última Polissonografia = melhor pressão
trapezoidal = 8,0 cmH₂O.

Dra. Claudina Freitas de Moraes Ogrizek
Clínica e Cirurgia de Ouvidos, Nariz e Garganta
CRM 58327

14/01/26.

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: MARIA APARECIDA DE ASSIS SANTOS

Sexo: Feminino

Data do Exame: 03-12-2025

Idade: 75 anos

Peso: 75 kg

Altura: 1,62 m

Médico Solicitante: DRA. CLAUDINA FREITAS DE MORAES OGRIZEK

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 03/12/2025 22:03 e finalizado às 04/12/2025 05:44.

A latência para início do sono foi de 1,5 min e a latência para o sono REM de 61,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 333,5 min, com eficiência do sono de 72,4 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 2,8 % de estágio N1, 55,5 % de estágio N2, 20,4 % de estágio N3 e 21,3 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 125,5 min. Ocorreram 18 despertares, sendo o índice de 2,3 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 25, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 25 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 4,5 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 13,5 e o IDR durante o sono NREM foi de 2,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 4,5 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 4,5 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 93%, a média de 91% e a mínima de 83%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 3,3 (nº/h), sendo que em REM foi de 14,4 (nº/h) e em NREM foi de 1,8 (nº/h). Permaneceu 12,3 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8,0 cmH₂O.

Seg: 22-15 horas
Ter: 15-20 horas noturnas
Qua: 20 horas até 22 horas

Nota: O diagnóstico depende da correlação com os dados clínicos.

Dr. José Maria Mendes da Costa
Médico Especialista
CRM 1150

Nome: MARIA APARECIDA DE ASSIS SANTOS

Data do Exame: 03-12-2025

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório normal (**4,5 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Dessaturação da oxi-hemoglobina (**83%**);
3. Latência para o início do sono diminuída (**1,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM diminuída (**61,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (**72,4 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares normal (**2,3 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (**2,8 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Ligeiro aumento do percentual do estágio N2 (**55,5 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**20,4 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (**21,3 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco moderado, intermitente verificado via sensor de ronco;
12. Presença de atividade em EMG de queixo.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

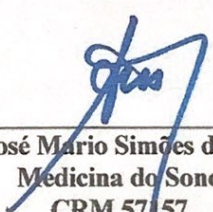
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157